

La dysfonction sexuelle féminine désigne des problèmes persistants liés au **désir**, à **l'excitation**, à **l'orgasme** ou à **la douleur pendant les rapports** qui vous dérangent. C'est fréquent à tout âge, souvent multifactoriel — physique, hormonal et émotionnel — et très souvent traitable. C'est un sujet médical légitime ; votre équipe soignante peut vous aider sans jugement.

À propos de cette affection

Les préoccupations entrent habituellement dans une ou plusieurs catégories :

- **Désir** — faible intérêt pour la sexualité
- **Excitation** — difficulté à s'exciter ou à maintenir l'excitation ; sécheresse vaginale
- **Orgasme** — difficulté à atteindre l'orgasme
- **Douleur** — gêne pendant ou après les rapports (dyspareunie)

Causes

Souvent une combinaison de facteurs :

- **Ménopause / faible taux d'œstrogènes** — sécheresse vaginale et amincissement des tissus (syndrome génito-urinaire de la ménopause, SGM)
- Un **plancher pelvien tendu ou douloureux**, un prolapsus ou des fuites urinaires
- Maladies, chirurgies antérieures et certains **médicaments** (ex. : certains antidépresseurs)
- Stress, humeur, sommeil et facteurs relationnels

COMPRENDRE LES TERMES

Libido

Désir ou intérêt sexuel.

Excitation

Réponse physique du corps, incluant la lubrification.

Dyspareunie

Douleur pendant ou après un rapport sexuel.

SGM

Syndrome génito-urinaire de la ménopause — sécheresse et amincissement dus à un manque d'œstrogènes.

Œstrogènes vaginaux

Traitement local à faible dose contre la sécheresse et l'inconfort.

Kinésithérapie du plancher pelvien

Thérapie pour les douleurs liées à une tension musculaire pelvienne.

Lubrifiant / hydratant

Produits sans hormones qui réduisent la sécheresse et le frottement.

EST-CE QUE C'EST "DANS MA TÊTE" ? Non. Il existe des causes physiques réelles et traitables — sécheresse vaginale, plancher pelvien tendu, prolapsus, effets des médicaments — auxquelles s'ajoutent des facteurs émotionnels et relationnels tout aussi importants. Une bonne évaluation les prend tous en compte, et la plupart des personnes constatent une amélioration significative.

Comment on le diagnostique

- Une conversation bienveillante et confidentielle sur vos préoccupations et vos antécédents
- Un examen pour identifier les causes physiques traitables (sécheresse, tension du plancher pelvien, prolapsus)
- Une révision de vos médicaments et de votre état de santé général

Comment on le traite

- 1 **Soulager la sécheresse et la douleur** — lubrifiants et hydratants, et **œstrogènes vaginaux** en cas de sécheresse liée à la ménopause.
- 2 **Kinésithérapie du plancher pelvien** en cas de douleur ou de tension musculaire.
- 3 **Traiter les facteurs associés** — prolapsus, fuites urinaires ou médicaments réduisant le désir.
- 4 **Thérapie / sexothérapie** et prise en charge de l'humeur, du stress, du sommeil et de la relation.

Conseils pratiques

- Utilisez un bon **lubrifiant** lors des rapports et un **hydratant** régulièrement contre la sécheresse.
- Une communication ouverte avec votre partenaire réduit la pression et la douleur.
- Donnez du temps aux traitements ; combiner plusieurs approches donne souvent de meilleurs résultats.

Informez votre équipe soignante si vous avez :

- Une nouvelle douleur, une **grosesse ou masse**, ou des saignements inhabituels
- Des saignements après un rapport ou après la ménopause
- Une inquiétude concernant votre sécurité dans votre relation

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les préoccupations sexuelles — désir, excitation, orgasme ou douleur — sont fréquentes, ont des causes réelles et sont généralement traitables.
2. De nombreuses causes sont physiques et corrigibles (sécheresse, plancher pelvien tendu, médicaments) ; les facteurs émotionnels et relationnels comptent aussi.
3. N'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante. Signalez toute nouvelle douleur, masse ou saignement après un rapport ou après la ménopause.